

気分障害

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター
精神科・緩和ケアセンター
奥山 徹

気分障害：目次

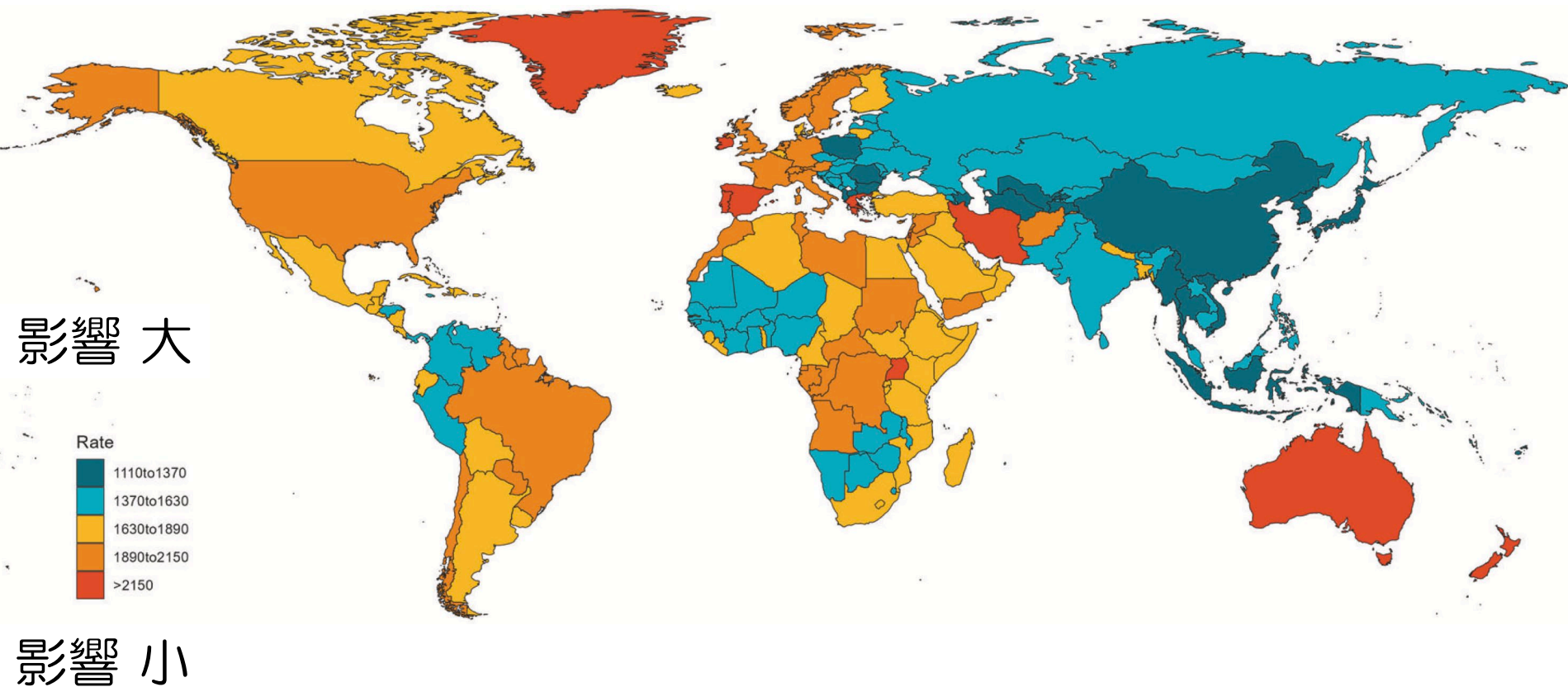
- 総論
- 疾病分類と診断基準
- 疫学
- 成因
- 治療
- 経過と予後

気分とは

- 気分：個人の経験を彩る、広範で持続的な情緒
 - 例：抑うつ、高揚、怒り、不安
- 感情：主観的に体験している気持ちの状態の表現
 - 例：悲しみ、怒り
- 違いは持続期間にある
 - 天候と天気
- 気分の異常として問題になるものとして、うつ状態と躁状態がある

精神疾患が健康に与える影響はアジアで大きい

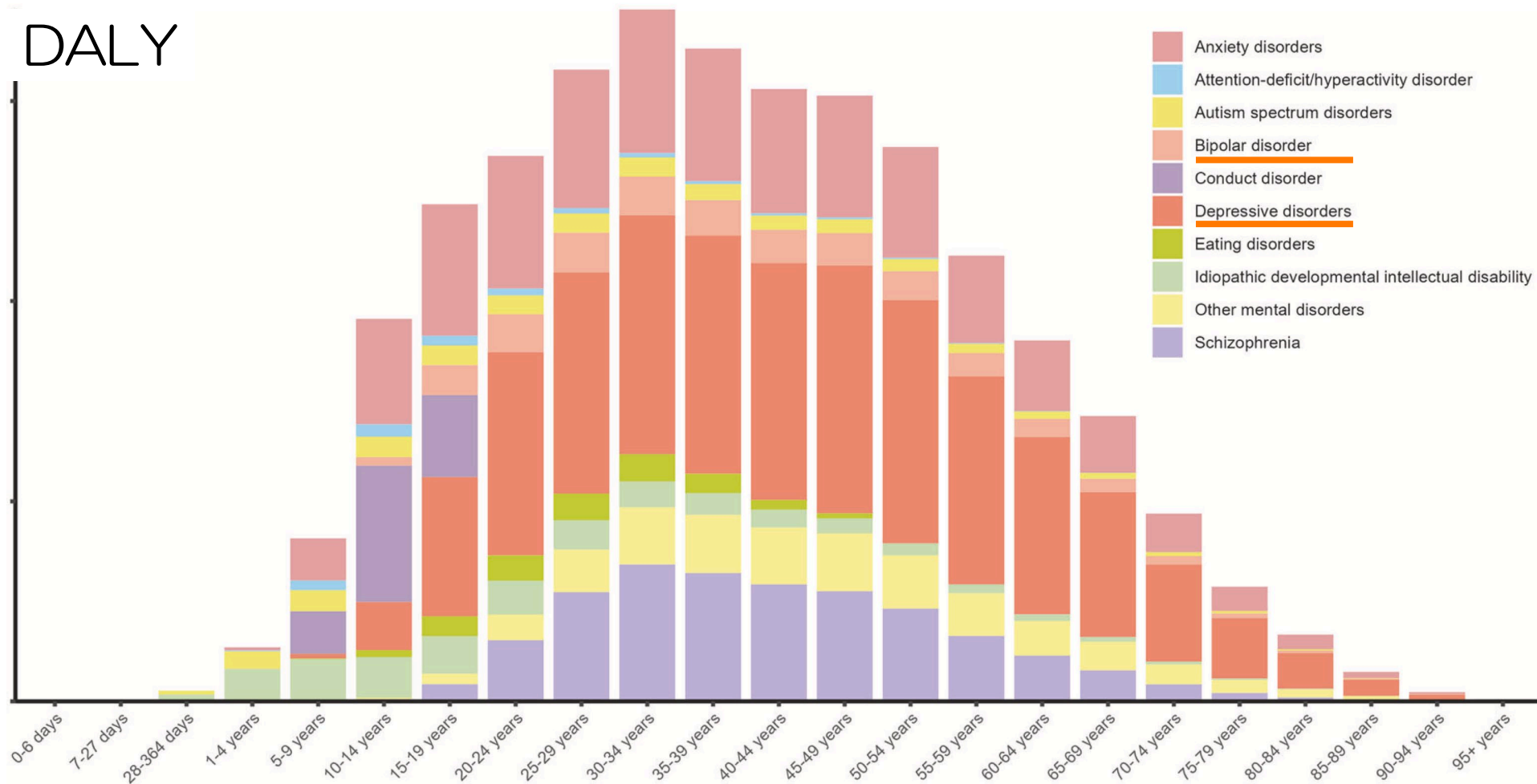
アジアにおけるglobal burden of disease study



Chen Q, et al, Transl Psychiatry 2024

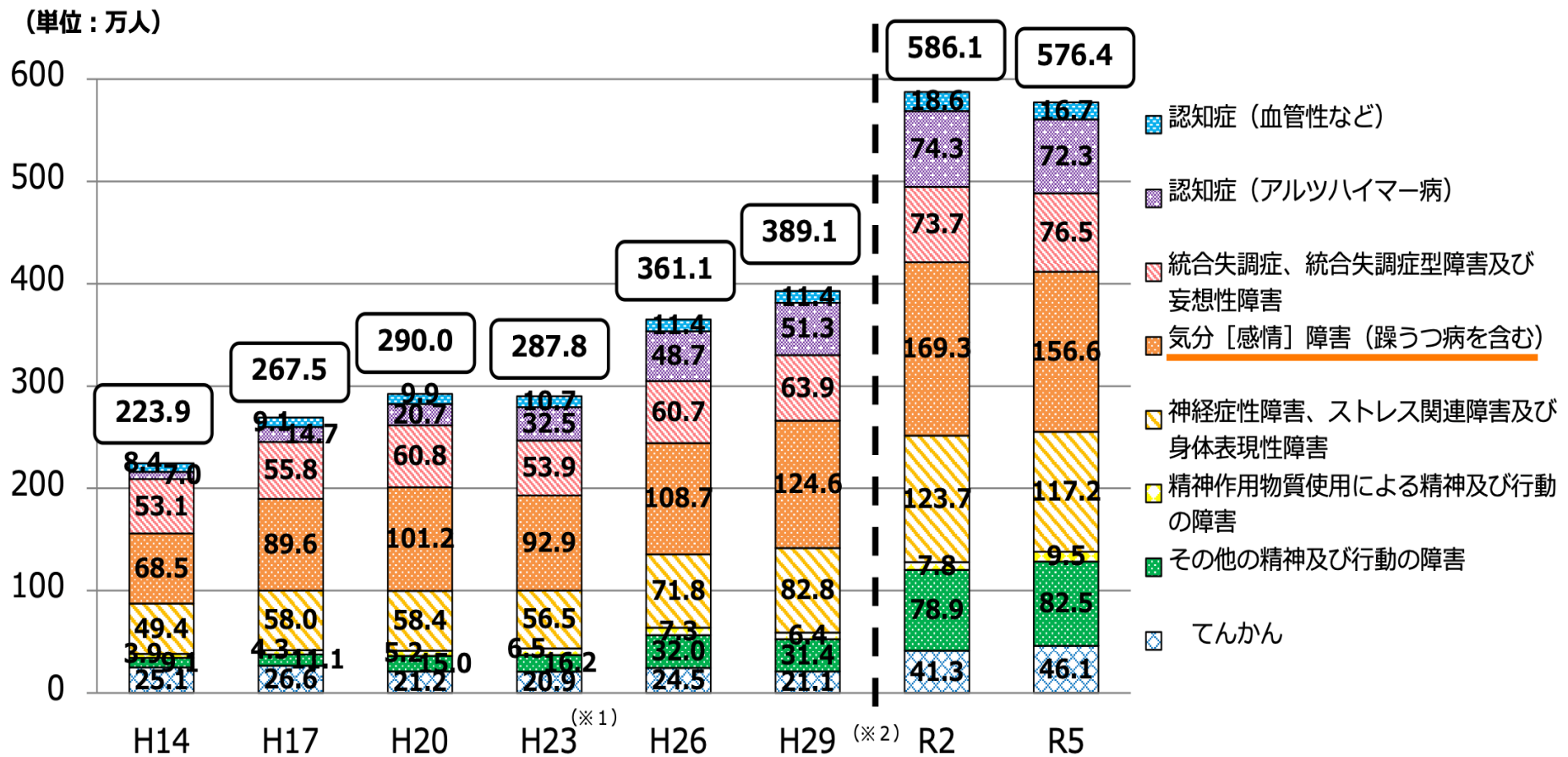
気分障害の健康へのインパクトは大きい

アジアにおけるglobal burden of disease study



Chen Q, et al, Transl Psychiatry 2024

精神科診断別患者数の推移



No health without mental health

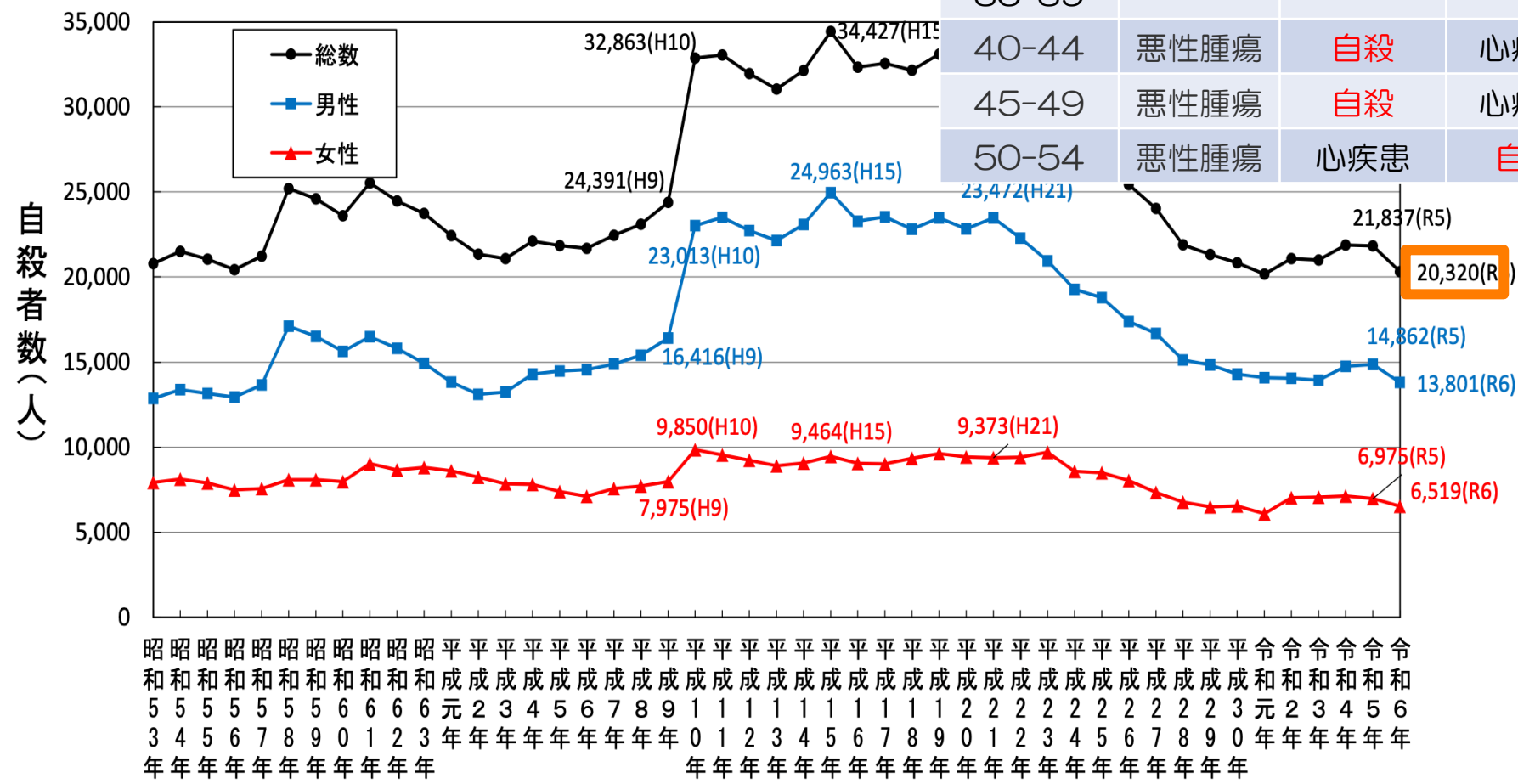
Prince M et al, Lancet 2007

精神疾患(MD)	身体疾患(HC)	MDはHCの危険因子	MDはHCの結果	因果関係を問わない合併	MDがHC治療遵守に影響	MDがHC予後に影響
うつ病	冠疾患	4	3	3	2	3
うつ病	脳卒中	3	3	3	0	3
主要精神疾患	糖尿病	1	2	3	3	3
主要精神疾患	HIV/AIDS	2	2	4	3	3

数字が大きいほど関連が強い

自殺者数の年次推移

年齢	1位	2位	3位
10-14	自殺	悪性腫瘍	事故
15-19	自殺	事故	悪性腫瘍
20-24			
25-29	自殺	悪性腫瘍	事故
30-34	自殺	悪性腫瘍	心疾患
35-39			
40-44	悪性腫瘍	自殺	心疾患
45-49	悪性腫瘍	自殺	心疾患
50-54	悪性腫瘍	心疾患	自殺



うつ病は見逃されやすい

- 気持ちが落ち込むことは誰にだってある
 - うつとうつ病の違いは天気と天候の違い
 - 2週間以上ずっとその状態が続くときは要注意
- まさか自分が
 - 大変なときには自分の状態が把握できないことが多い
- 体の症状もうつのサイン
 - だるさ、食欲不振、不眠などもうつの症状
- 気持ちを打ち明けることの抵抗感
 - つらい時にはまず言葉にすることが重要

うつ病に関する誤解

- 本人が精神的に弱いためにかかる病気？
 - 誰にでもなりうる状態です
- なまけているだけでしょう？
 - 真面目で責任感の強い方こそなりやすいと言われています
 - がんばりすぎてオーバーヒートになっているので、休養が最も大切です
- 失恋や仕事の失敗で落ち込むことなんて誰でもあるさ？
 - でも、その状態が長く続くときには病気としての治療が必要です

気分障害：目次

- 総論
- 疾病分類と診断基準
- 疫学
- 成因
- 治療
- 経過と予後

気分障害：DSM-IVからDSM-5へ

- DSM-IV: 双極性障害、うつ病性障害を全て含んで「気分障害」
- DSM-5: 双極性障害と抑うつ障害群に分離
- 双極性障害：躁病エピソード基準A項目に「目標指向性の活動の亢進」追加
- うつ病性障害：
 - DSM-5で持続性抑うつ障害が新設：DSM-IVの気分変調症と慢性うつ病が統合
 - DSM-5では、死別反応に伴ううつ状態もうつ病に含めることに

- 双極性障害をうつ病と誤診しやすい
 - うつ状態で経過する期間が長い
 - 7年間の経過中、30%程度の期間が抑うつ、10-15%が躁・軽躁だったとの報告あり
 - うつ状態となって受療することが多い
- 双極性うつとうつ病は異なった疾患
 - 疫学的な相違(遺伝性、自殺企図率など)
 - 異なった治療
 - より双極を疑うべき特徴：双極性障害の家族歴、25歳以下の発症、6ヶ月以下のエピソードが頻回、不眠より過眠、食欲不振より過食

- **エピソード** episode
 - それ自身は診断コードをもたず、独立して疾患単位として診断することはできない
 - しかし、疾患の診断の構成要素となる
 - 4種類のエピソード(躁病、軽躁病、抑うつ、混合性)が定義されている
- **障害** disorder
 - エピソードの有無や、異なったエピソードの組み合わせなどで診断を行う

躁病エピソード

重要

- A、B項目が1週間以上持続
- A項目(必須)：気分高揚・開放的または易怒的、目標指向性の活動の亢進
- B項目：3つ以上(A項目が易怒的のみなら4つ以上)

自尊心の誇大性

睡眠欲求の減少

多弁

観念奔逸

注意散漫

目標指向性活動の亢進

逸脱行動

(行為心迫)

- 著しい苦痛または機能障害、入院が必要であるほど重篤
- 混合性エピソードは満たさない

軽躁病エピソード

重要

- 基本的には躁病エピソードと同様だが・・・
 - A、B項目持続は4日以上
 - 社会的に著しい障害を起こすほど、または入院を必要とするほど重篤ではない
 - 精神病性の特徴は存在しない

国家試験過去問

- 双極性障害の躁状態でみられる症状はどれか。
2つ選べ。
 - a 観念奔逸
 - b 思考制止
 - c 談話心迫
 - d 微小妄想
 - e 妄想気分

抑うつエピソード

重要

- A項目のうち5項目以上が、2週間以上ほとんど毎日存在し、かつ1. または2. が必須

1. 抑うつ気分

2. 興味・喜びの喪失

3. 食欲・体重増加／減少

4. 不眠、または睡眠過多

5. 精神運動制止／焦燥

6. 易疲労感

7. 無価値感、罪責感

8. 注意集中力低下、決断
困難

9. 希死念慮

- 著しい苦痛または機能障害

国家試験過去問

- 患者の訴えのうち、抑うつ状態を最も疑わせるのはどれか？
 - a「すぐにかっとなってしまいます」
 - b「何をするのも億劫で仕方ありません」
 - c「なんとなく落ち着かない気持ちになります」
 - d「昼間にうとうとすることが多くなりました」
 - e「外で誰かに見られているような気がします」

混合性の特徴を伴う

- 躁病・軽躁病エピソードにおいては、抑うつ気分、興味・喜びの消失、精神運動制止、易疲労感、無価値観・罪責感、希死念慮のうち、3項目以上を満たす場合
- うつ病エピソードにおいては、気分高揚（易怒性は含まない）、自尊心の誇大性、睡眠欲求の減少、多弁、観念奔逸、逸脱行動、目標指向性の活動の増加のうち、3項目以上を満たす場合
- 躁病・軽躁病エピソードを満たす場合は、双極性障害と診断し、満たさない場合はうつ病と診断する。

DSM-5 双極性障害、関連症候群

重要

障害	躁病エピソード	抑うつエピソード
双極I型障害	躁病または混合エピソードあり	抑うつエピソードあることが多いが、 診断には不要
双極II型障害	一回以上の軽躁病エピソード(躁病または混合エピソード既往なし)	抑うつエピソードが存在
気分循環性障害	2年以上に渡る軽躁病基準を満たさない多数の軽躁症状エピソード	2年以上に渡るうつ病基準を満たさない多数の抑うつエピソード
特定不能の双極性障害	躁症状があるが、上記のどの障害の基準も満たさない	不要

仮想症例：30代 男性 無職

- 家族歴：父親が自殺。
- 中学、高校時代にいじめに会い、不登校となったことがある。高校卒業後会社員となり、特に不適應となることもなく勤務できていた。
- 数ヶ月前に昇進、職務が増えてストレスを感じるようになり、夜眠れなくなった。しかし寝なくても全く問題ないように感じ、深夜にランニングをしたりするようになった。
- 一ヶ月前より、これまでしないような散財をするようになった。また多弁、イライラ、易怒的となり職場でのトラブルが増え、上司が見かねて病院を受診させた。診察時、本人は易怒的で、「自分は病気じゃない！」と大声を上げる。

DSM-5 抑うつ障害群

重要

障害	躁病エピソード	抑うつエピソード
うつ病	躁病、軽躁病エピソードの既往なし	抑うつエピソードあり (単一／複数)
持続性抑うつ 障害 (気分変調症)	躁病、軽躁病エピソードの既往なし	抑うつ気分2年以上 (うつ病基準満たさない)

仮想症例：50代 男性 商店主

- これまで大きな病気もなく元気にやってきた。建具屋をしていたが、この5年ほど売り上げが減り、数ヶ月ほど前からお金の心配が頭から離れなくなった。
- 半年ほど前から眠れなくなり、いつになく疲れやすく、食欲や気力も落ちたので、近所の医者にも診てもらい、また人の勧めで人間ドックにも入ったが、「どこも悪くない」と言われた。
- 周りにも迷惑をかけるし、こんな状況が続くなら死んだほうが良いというようになったため、家族に連れられて来院した。

不安性の苦痛を伴ううつ病

重要

- うつ病エピソード中、以下2つ以上を満たす
 - 張りつめた、または緊張した感覚
 - 異常に落ち着かないという感覚
 - 心配のための集中困難
 - 恐ろしいことが起こるかもしれないという恐怖
 - 自分をコントロールできなくなるかもしれないという感覚
- 難治性で、希死念慮が高い
- 精神病を伴うことも伴わないこともある
- 双極性障害や混合病エピソードとの関連が示唆

症例：47歳 女性 主婦

- 既往歴：10年前に椎間板ヘルニアを患い、家族の世話や仕事もこなせなくなったことを機にうつ病となり、これまで2回の入院歴がある。
- 今回半年ほど前に次男が不登校となったことから具合が悪くなり、家族に連れられて来院した。
- 受診時は混乱状態にあり、表情は硬く、何を質問しても「大変なんです」「いろいろ考えて頭が壊れそうで・・・」と繰り返すのみで、疏通性は不良で会話も成立しがたい状態であった。焦燥・困惑感、罪悪感が前景にあった。

メランコリアの特徴を伴ううつ病

重要

- うつ病、双極IあるいはII型におけるうつ病エピソードに適用できる
- 以下のどちらかが必須
 - ほとんど全ての活動における喜びの低下
 - 快適である刺激に対する反応の消失
- 随伴症状(以下の3つ以上)
 - はっきり他と区別できる抑うつ気分(重篤な)
 - 抑うつは決まって朝に悪化
 - 早朝覚醒(2時間以上)
 - 著しい精神運動制止／焦燥
 - 有意の食欲不振／体重減少
 - 過度または不適切な罪責感

メランコリアの特徴を伴ううつ病

重要

- イコール内因性(遺伝性)うつ病？
 - うつ薬やECTなどの治療への反応性良好
 - プラセボへの反応に乏しい
 - 生理学的な異常を認めやすい
 - EEG
 - 高コルチゾール血症
 - Dexamethasone suppression test
- 現時点では、明らかな内因性、明らかな反応性も各少数はあるだろうが、現在のうつ病モデルとしては、遺伝とストレス体験の相互作用が考えられている

Acta Psychiatr Scand 2007 Suppl. 433

国家試験過去問

- 心因性うつ病と比較して、内因性うつ病の特徴として、誤っているものはどれか？
 - a 抑うつと制止
 - b 身体症状を伴いやすい
 - c 自殺の危険がある
 - d 日内変動がある
 - e 入眠障害よりも早朝覚醒が目立つ

非定型の特徴を伴ううつ病

重要

- うつ病エピソード中、以下の特徴を満たす
 - A：気分反応性(楽しい出来事で明るくなれる)
 - B：以下の2つ以上
 - 著明な体重増加、あるいは食欲増加
 - 過眠
 - 手足の重さ
 - 長期間にわたる対人関係の拒絶への敏感さ
- メランコリー型を定型とした場合の「非定型」
- 三環系抗うつ薬よりもSSRIに反応しやすい
- 高齢者より若年者に多い

- 頻度：うつ病で10%以上、⇒鑑別診断として重要
- 気分一致した妄想
 - 抑うつ：罪業妄想、貧困妄想、心気妄想
 - 躁：誇大妄想、血統妄想
- 気分不一致な妄想
 - 被害妄想、思考伝播など
 - うつ病、双極性障害ともに、気分不一致な妄想は予後不良因子とされる

国家試験過去問

- うつ病の患者で、抑うつ気分と関連してみられる妄想はどれか。2つ選べ。
 - a 被毒妄想
 - b 迫害妄想
 - c 憑依妄想
 - d 罪業妄想
 - e 貧困妄想

国家試験過去問

- うつ病について正しいのはどれか？
 - a 意識が高度に障害される
 - b 幻覚を伴う病型がある
 - c 思考が障害されることはない
 - d 夕方に抑うつ気分が強くなる
 - e 慢性化することは少ない

国家試験過去問

- 75歳男性 最近言動がおかしいことに気付いた家族に伴われて来院。半年ほど前から「気が滅入る」といい、1日中臥床がち。食欲不振、体重減少、意欲減退あり。「自分はがんでもうすぐ死ぬ」「我が家は破産だ」といい、酒を飲まないと眠れない。
- 診断は？
 - a うつ病
 - b 意識障害
 - c 認知症
 - d アルコール依存症
 - e 統合失調症

季節型うつ病

- うつ病エピソードの発症と1年における特定の時期との間に規則的時間関係
- 寛解時期も特定の時期におこる
- 最近2年間に季節関係を示すエピソード2回、同じ期間に非季節性エピソードがない
- 季節性エピソードが、非季節性エピソードよりずっと多い
- 臨床的特徴
 - 典型的には秋・冬に病状悪化
 - 過眠、過食、体重増加
 - 高照度光療法が有効

- 抑うつ気分がほとんど1日中存在し、それが2年間以上持続。期間中半分以上は抑うつ的に経過、2ヶ月続けてよくなることはない

- B項目2つ以上

食欲不振／過多

不眠／過眠

気力の減退、疲労

自尊心の低下

集中力低下、決断困難 絶望感

- 5年で自然寛解は53%、回復しても45%が2年弱で再発

- うつ病を合併する率も高い(double depression)

Klein et al, Am J Psychiatry, 2000

一般身体疾患による気分障害(1)

- 顕著かつ持続性の気分の障害
 - 抑うつ気分／興味・喜びの低下
 - 高揚した、開放的な、またはいらだたしい気分
- 身体疾患の直接的生理学的結果であるという証拠
- うつ病や躁病エピソードを満たしている必要はない

一般身体疾患による気分障害(2)

- 原因疾患

- 神経性疾患：パーキンソン病、ハンチントン病
- 脳血管疾患：脳卒中
- 内分泌疾患：甲状腺機能亢進／低下症、副甲状腺機能亢進／低下症など
- 自己免疫疾患：SLE
- 感染症：AIDS、肝炎
- がん

物質誘発性気分障害(1)

- 顕著かつ持続性の気分の障害
 - 抑うつ気分／興味・喜びの低下
 - 高揚した、開放的な、またはいらだたしい気分
- 薬物関連であることの証拠
 - 物質中毒／離脱の期間中、またはその1ヶ月以内に出現
 - 投薬の使用がその障害と病的に関連
- うつ病や躁病エピソードを満たしている必要はない

物質誘発性気分障害(2)

- 原因物質
 - 中毒中に起こりうる：アルコール、アンフェタミン、フェンシクリジン、抗不安剤など
 - 離脱中に起こりうる：アルコール、アンフェタミン、抗不安剤など
- うつ病を来たしやすい薬物として**レセルピン、ステロイド、インターフェロン**などは臨床的に重要

国家試験過去問

- 68歳女性。2か月前からうつ状態。金銭問題はないにもかかわらず、「所得税が払えない。」と訴える。食事減少あり。眠らず、ぶつぶつ言っている。質問には小声で短く答え返答に時間がかかる。改訂長谷川式簡易知能評価スケールは26点。「薬代を払えない」と治療を拒否。神経学的所見異常なし。甲状腺機能を含めた血液検査所見に異常なし。最も考えられるのは？
 - a 気分障害
 - b 適応障害
 - c 症状性精神病
 - d 脳血管性認知症
 - e 恐怖症性不安障害

気分障害：目次

- 総論
- 疾病分類と診断基準
- 疫学
- 成因
- 治療
- 経過と予後

気分障害の疫学

重要

	時点有病率	生涯有病率	性	発症年齢
うつ病	2.3-5.6	16.1	F > M	30代前後
気分変調症	3	6	F > M	10-20代
双極I型障害	0-2.3	1.0-4.0	F = M	15-24 (老年期なら 身体疾患を 疑う)
双極II型障害		1.1	F > M	
気分循環性 障害		0.4-1	F = M	10-20代
双極性障害 全体		0.8-13.5 (5%前後)		

国家試験過去問

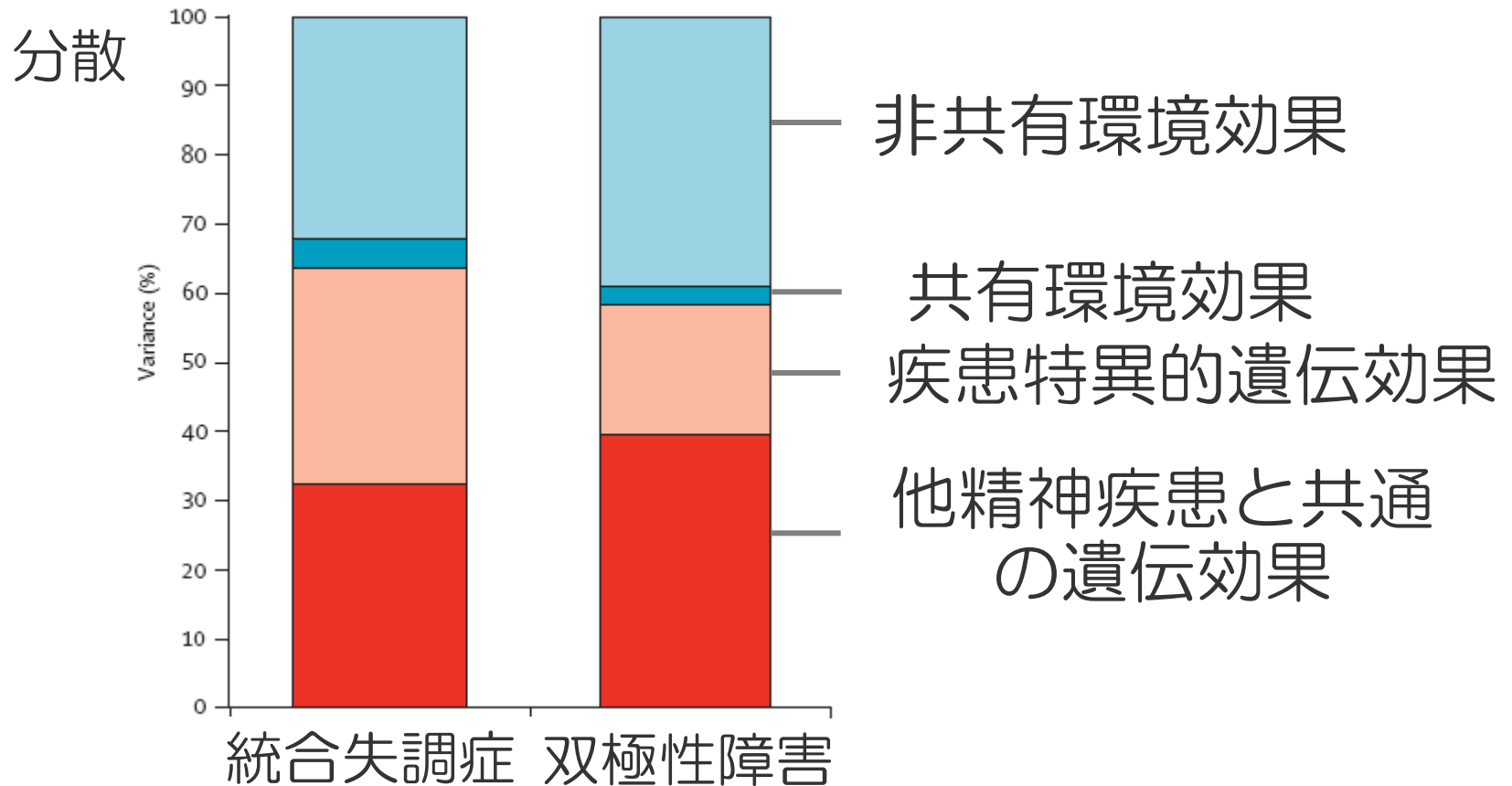
- 平成8年と平成26年の患者調査を比較して、患者数が最も増加したのはどれか。
 - a 気分障害
 - b 統合失調症
 - c 血管性認知症
 - d アルコール依存症
 - e 神経性食思不振症

気分障害：目次

- 総論
- 疾病分類と診断基準
- 疫学
- 成因
- 治療
- 経過と予後

双極性障害発病に関する遺伝と環境の影響

- スウェーデンでの人口登録データ
- 900万人、200万家族のデータを解析

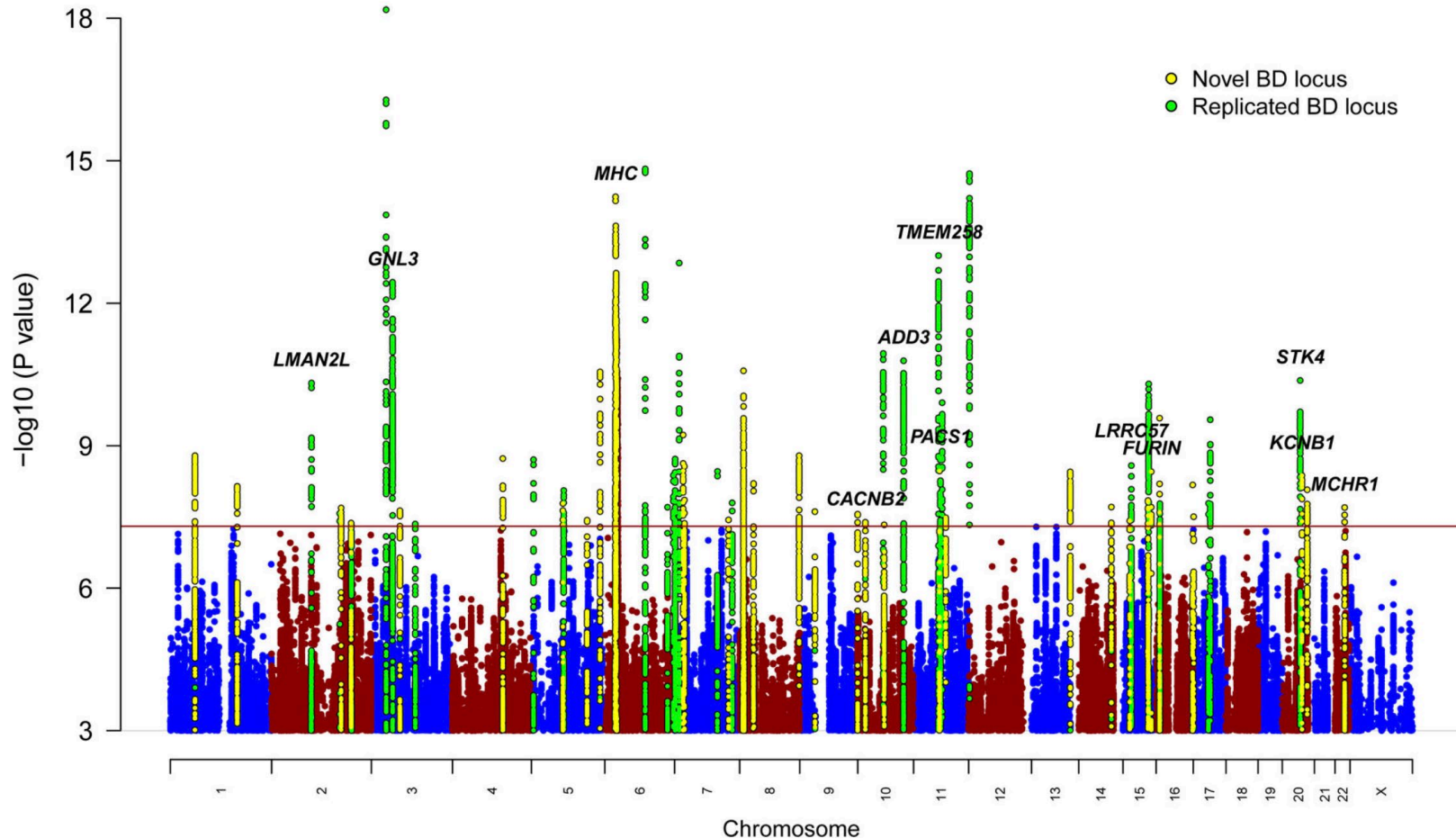


Lichtenstein et al. Lancet 2009

参照：双極性障害 全ゲノム関連解析

- 40万人以上のデータを統合して解析

64個の遺伝部位が有意に関連

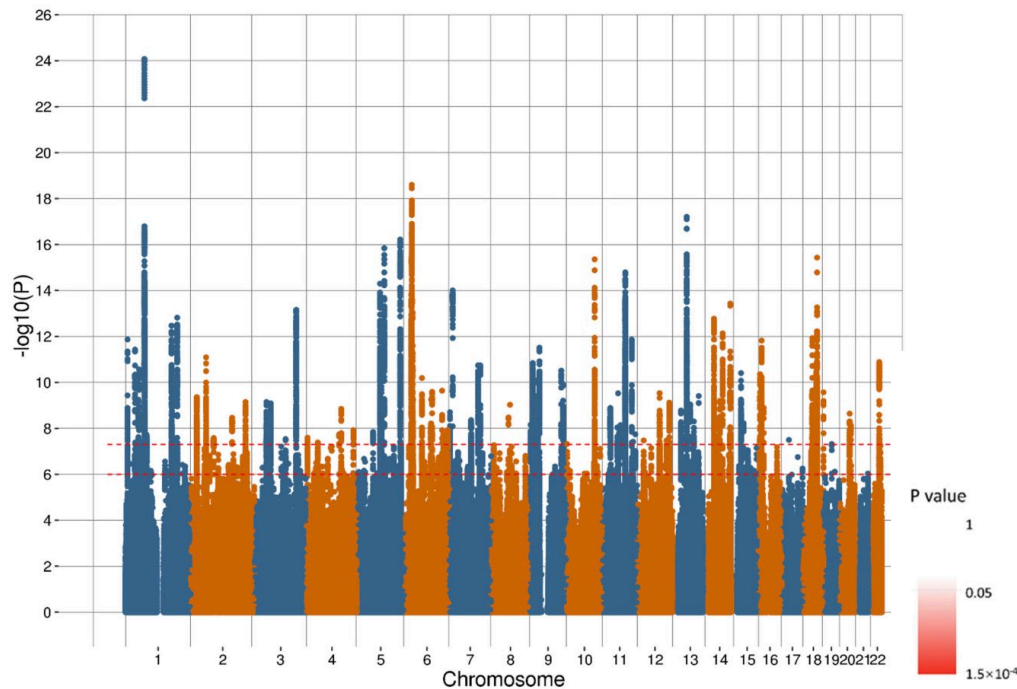


Mullins, et al. Nat Genet 2021

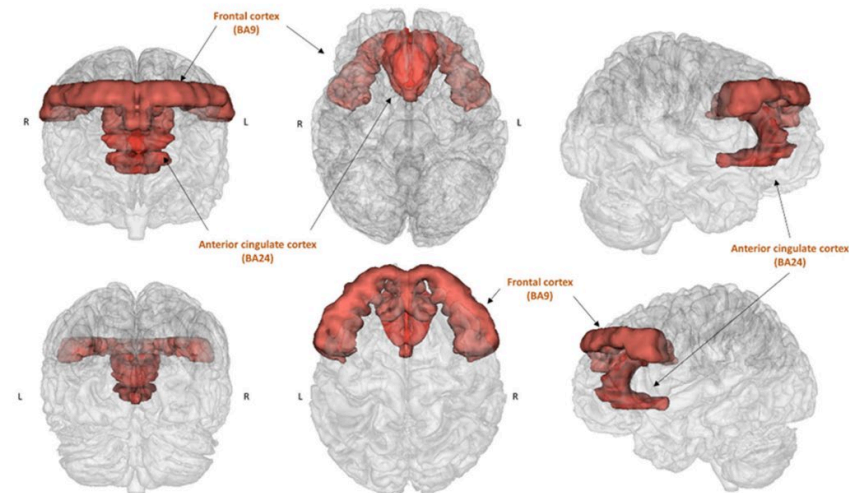
参照：うつ病 全ゲノム関連解析

- 80万人以上のデータを統合して解析

102個の遺伝部位が有意に関連

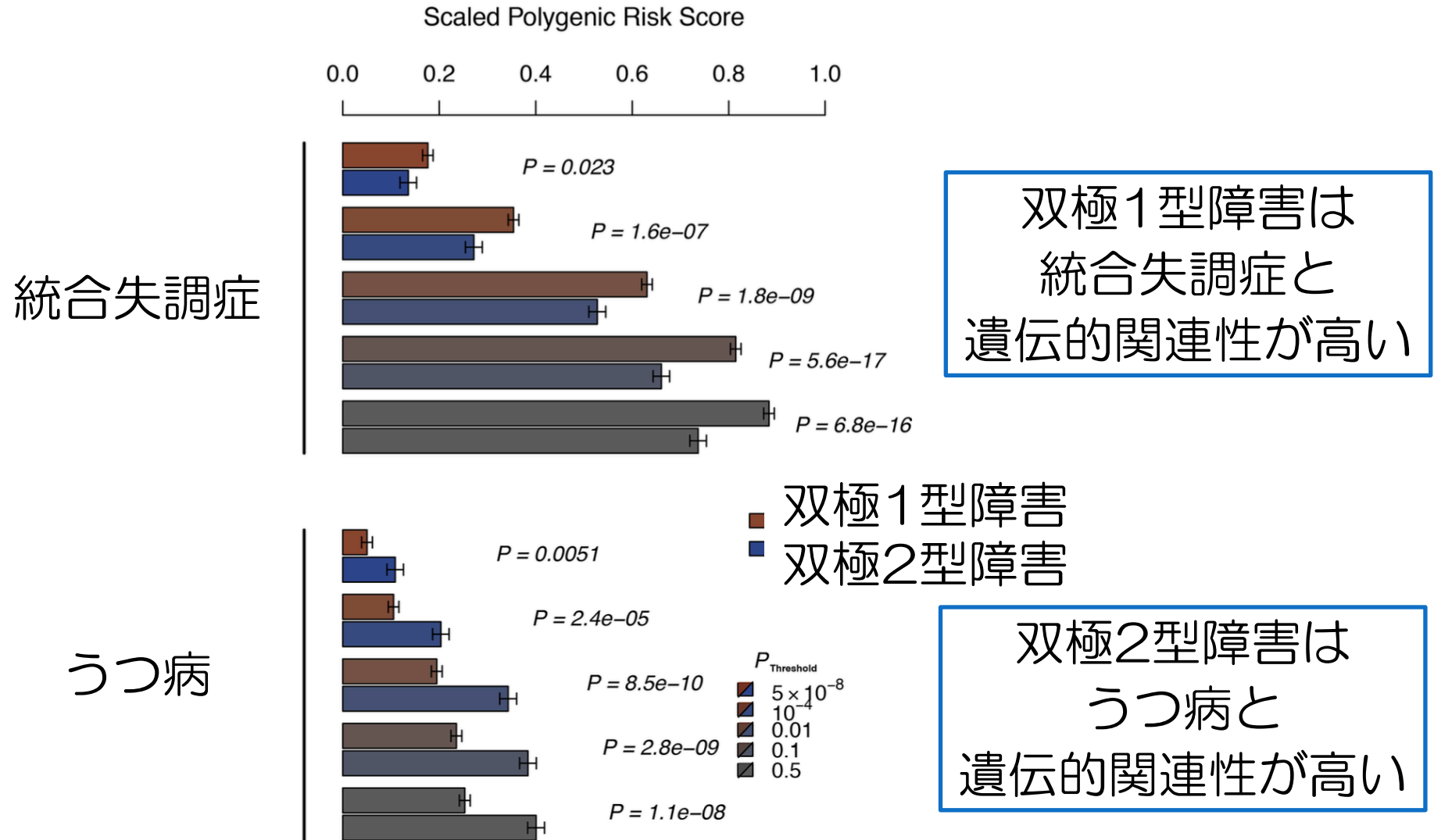


有意遺伝群は脳の前頭野に
集中して位置していた



参照：双極性障害と他精神疾患の遺伝関係

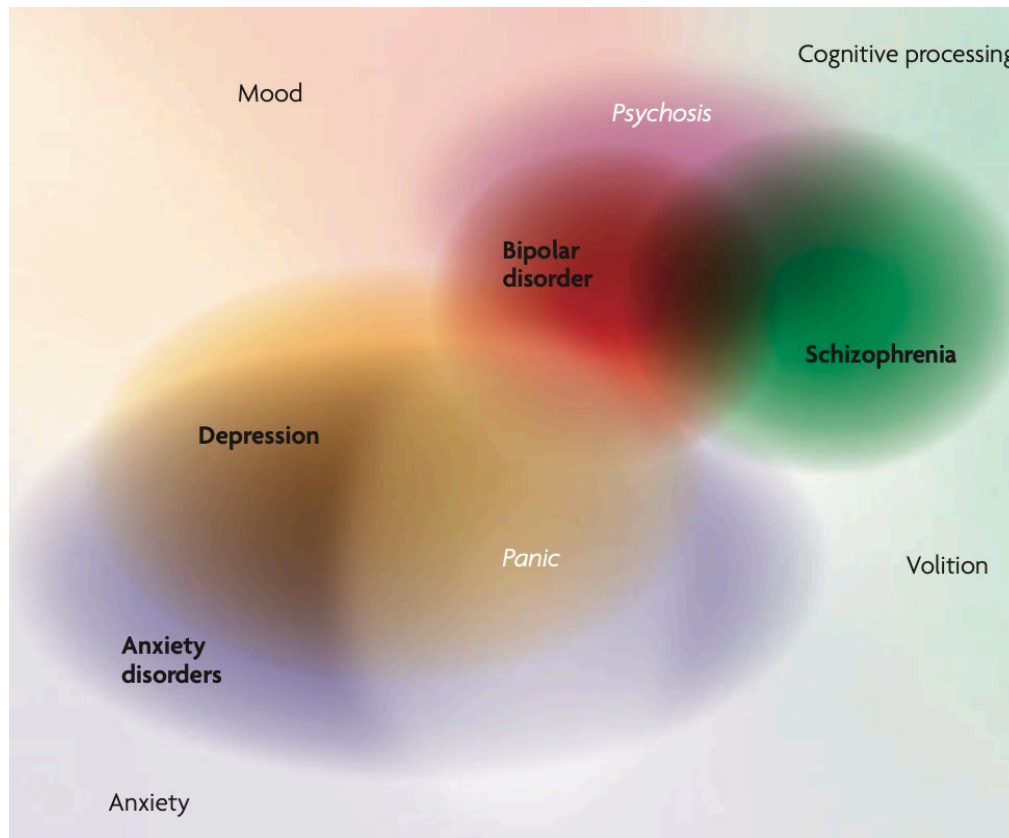
- 合計5万人以上のデータでの全ゲノム関連解析



- うつ病も双極性障害も多因子遺伝による多因子疾患
- うつ病：遺伝性はあるが、双極性障害ほどの強い関連はない
 - 説明率は20-40%
 - 家族性は若年発症と再発率に関連
- 双極性障害：遺伝的影響についての強い証拠が示されている
 - 説明率は75%
- 少なくともうつ病と双極性障害は同一疾患とは言いがたい
- 臨床においても家族歴を確認することが重要

参照：精神疾患同士では遺伝の重なりが想定

- 遺伝学的には、パーソナリティの極端な偏りとして精神疾患を考えることができそう
- 精神疾患同士には遺伝的な重なりがありそう



Burmeister M, et al. Nat Rev Genet 2008

モノアミン仮説

- モノアミン：アミノ基を一個だけ含む神経伝達物質の総称
- セロトニンの欠乏がうつ病に関連？
 - うつ病寛解患者において、トリプトファン(セロトニンの原料) 欠乏食はうつ病を誘発
 - 抗うつ剤の多くはシナプス間隙におけるモノアミンの再取り込み阻害をもつ
- しかし・・・
 - 抗うつ薬でセロトニンを増やしても、うつが改善するのには2－3週間の時間差
 - セロトニン異常を有さない患者もいる

Brain Derived Neurotrophic Factor

- 脳由来神経栄養因子：神経細胞の成長やシナプス可塑性(伝達経路の増強)に重要な役割
- BDNF活性化⇔セロトニン機能活性化の正のサイクル
- うつ病患者でBDNF低下⇒治療で正常化
- 抗うつ薬治療⇒セロトニン増加⇒海馬、大脳でBDNFを活性化⇒海馬神経新生⇒うつ病の改善？
- ラット：X線照射で海馬神経新生を阻害⇒うつが改善しない

ライフイベント

重要

- 多くの研究がうつ病の発症に対するライフイベントの先行を示している
- ライフイベントは寛解や再発にも関連する
- 遺伝的脆弱性があるものにストレスがかかるとうつになりやすい

Kendler KS, et al. Am J Psychiatry 1995

- ライフイベントの影響は、双極性障害よりもうつ病において大きい
- うつ病の遺伝的リスクは、ライフイベントに遭遇する確率を高めるかもしれない

Paykel et al, Acta Psychiatr Scand 2003

- クレッチマー：循環気質(陽気、社交的)と肥満体型
- 下田：執着性格(几帳面・生真面目、責任感)
- テレンバッハ：メランコリ親和型(秩序を重んじる、他人に尽くす)
- しかし現在のエビデンスでは
 - 単極性うつ病：神経症性傾向が確からしい
Costa, et al. Revised NEO Personality Inventory and the Five Factor Inventory 1992.
 - 双極性障害：平均的なものであるというのが現在の通説

うつ病の心理社会的要因

- 気持ちがつらくなることは誰にでも起こりうる
- 社会的弱者は、ストレスな出来事にも脆弱かもしれない

出生段階

- 遺伝
- 女性
- 性格傾向

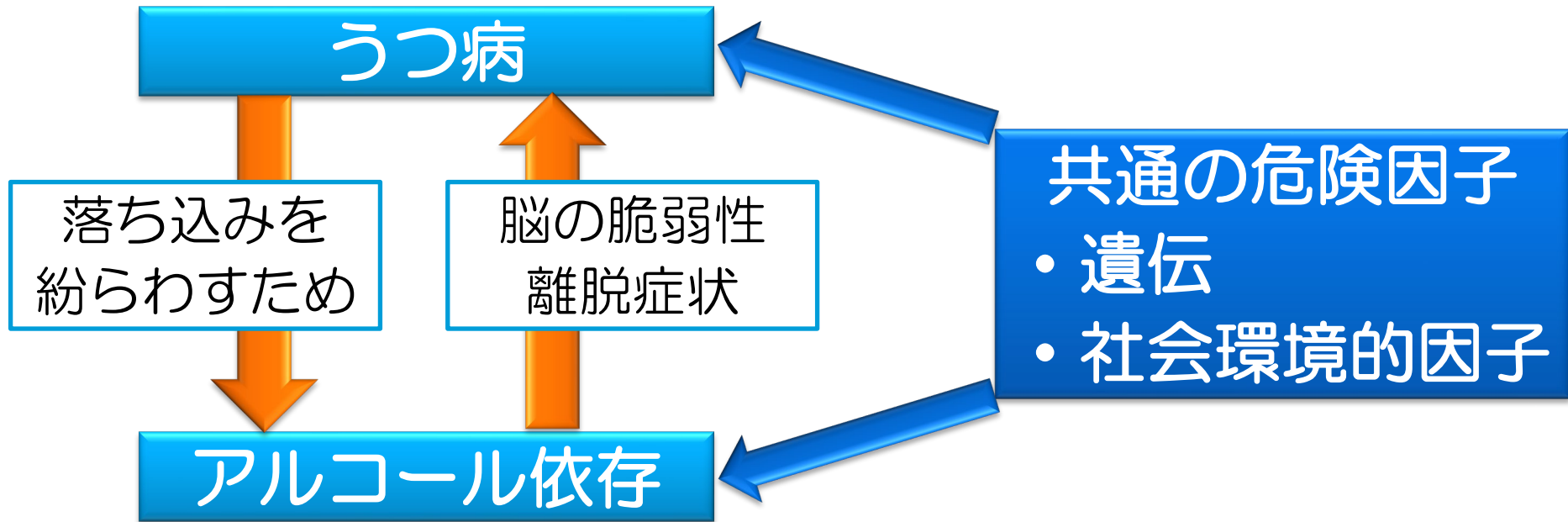
生育～出来事に遭遇する前の段階

- 不適切な生育
- 不遇な経済的環境
- 低い自己評価
- 少ない社会サポート
(独居、失業など)
- 過度の飲酒
- 内分泌的变化(例：周産期)

契機となる出来事

- 身体疾患
- 対人関係
- 経済的問題
- 人生の困難

うつ病とアルコール



- アルコールとうつ病は双方向的因果関係
- アルコール合併のうつ病は難治性
- アルコールもうつ病も自殺の危険因子、並存している場合はさらに注意を要する

国家試験過去問

- 仕事ができないという患者の訴えで、うつ病の可能性が高いのはどれか？
 - a 「やりたくないので仕事のことは考えない」
 - b 「やらないといけませんが頭が回らない」
 - c 「上司にすぐ怒られるのでしたくない」
 - d 「この仕事は自分にあっていません」
 - e 「ものを考えるとすぐ眠くなる」

国家試験過去問

- 31歳の男性。倦怠感で来院。大企業の事務職。職場を離れると症状なし、休日は症状なし。既往歴に特記すべきことはない。意識は清明。1か月前に行われた職場の健康診断とストレスチェックとで問題を指摘されていない。まず行うべきなのはどれか。
 - a 頭部CTを行う
 - b 甲状腺機能検査を行う
 - c 精神科受診を指示する
 - d 産業医との面談を勧める
 - e 市町村保健センターを紹介する

国家試験過去問

- 過重労働と気分の落ち込みとを訴える労働者が相談に訪れた。
- 産業医の最初の対応で適切なのはどれか。
 - a このまま様子を見る
 - b 精神科医に相談するように勧める
 - c 配置換えの希望を出すように勧める
 - d 労働基準監督署に届け出るように勧める
 - e 詳しい労働状況や心身の状態を把握する

こころの異常とは？

- 平均基準
 - 常識的な視点から外れたものを異常とする
 - その場合、正常と異常の境界は？
- 価値基準
 - 実用価値が劣る状態を異常とする
 - その場合、その基準に普遍性はあるか？
- 事例性
 - 社会的問題を来す状態を異常とする
 - その場合、環境、地域、時代などの影響
- 異常かどうかは大切ではない？
 - 患者さんの悩みやつらさが楽になれば良い

精神疾患の診断とは？

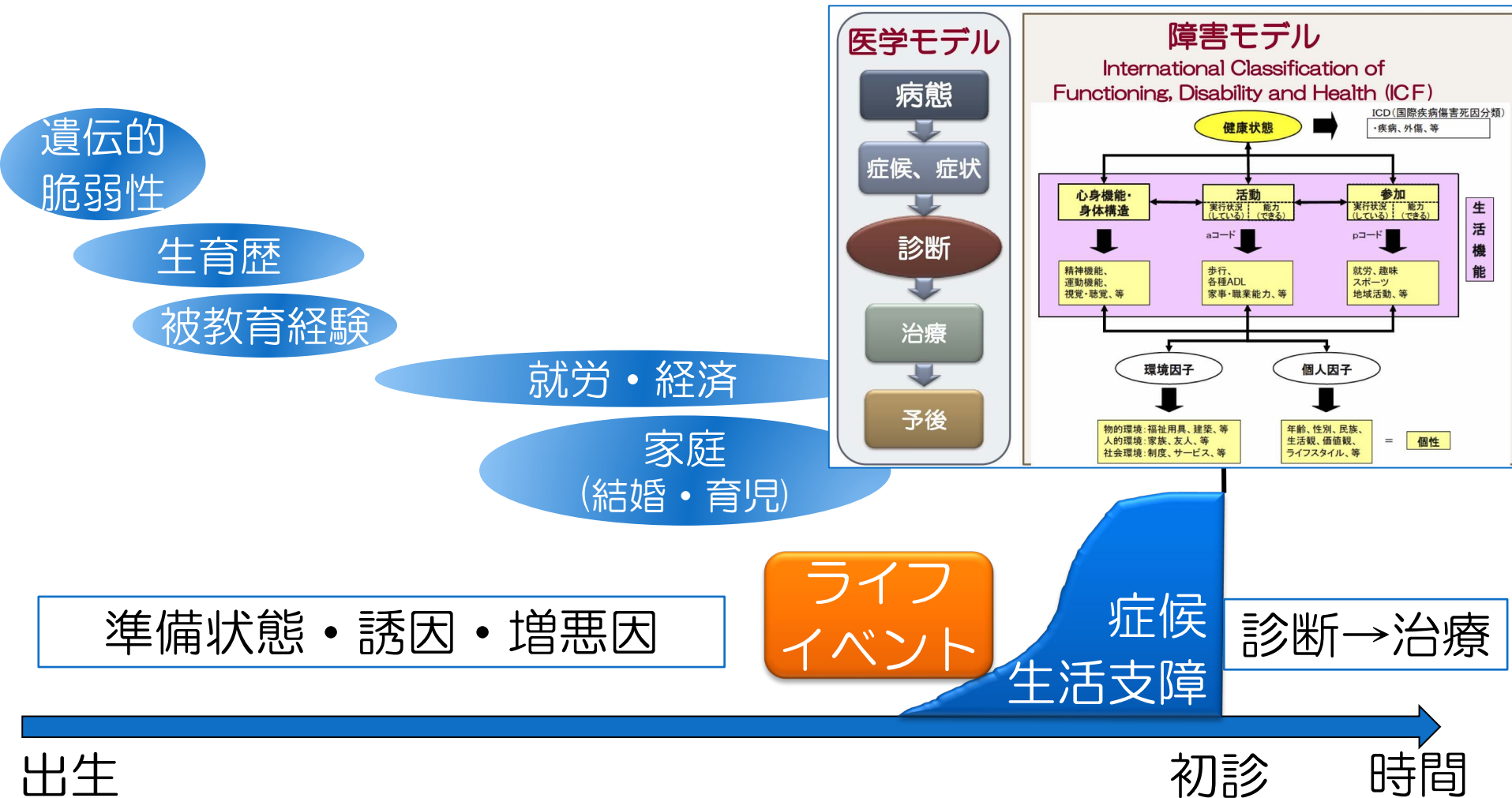
- 分類の不可避性
 - 特定の特徴によって区別し、名前を与える
 - 経験から学ぶこと、他の医療者とコミュニケーションをとることを可能にする
 - 病態解明、治療開発の基礎であり、結果を目前の患者に適用できるか判断する基準でもある
- 信頼性と妥当性
 - 信頼性：誰がやっても、何度やっても同じ結果
 - 妥当性：他の状態とは区別される特定の臨床的まとまりを表しているか

精神疾患の診断とは？

- 操作的診断基準(DSM-5など)
 - 誰が用いても正しく客観化される方法
 - 症状の数(例：9症状のうち5つ以上)
 - 持続期間(例：2週間以上)
 - 社会的支障がある
 - (半)構造化面接：面接の手順、質問内容を厳密に規定したもの
- 臨床診断
 - 操作的診断を用いてもバリエーションがある
 - 典型的に診断基準に当てはまらない場合も多い
 - フォーマレーションが大切(操作的診断に患者個人に固有の特徴を加味して総合判断)

ケースフォーミュレーション

- 診察情報をもとに、症状や障害を「病む人」のストーリーとして総合的に理解すること



ケースフォーミュレーションの一例

父親がうつ病
・アルコール依存

厳しいしつけ
→真面目・融通効かない

期待に応えて
一流大学卒業

一流企業勤務(仕事が生きがい)
・コミュニケーション不得意

結婚・子供が不登校
(奥様の負担大きい)

会社で失敗

自責感
将来悲観
希死念慮
出勤できない

うつ病と
診断

出生

初診

時間